Gestión de Muestras · 2º examen · Simulacro Test

Tema 2 · Funciones, áreas y organización del trabajo en el laboratorio · 80 preguntas de selección múltiple · Tiempo: 60 min · Soluciones al final

Instrucciones: una sola respuesta correcta por pregunta. Hazlo cronometrado y sin mirar el Repaso. Marca las dudosas y repásalas después en el Repaso.

Bloque A · TSLCB: funciones (1-20)

1. Las funciones del TSLCB son de:
a) Solo investigación, sin supervisión
b) Diagnóstico y prescripción de tratamientos de forma autónoma
c) Gestión económica del hospital
d) Diagnóstico, tratamiento, seguimiento e investigación, bajo supervisión del titulado universitario

2. El técnico debe aplicar las técnicas garantizando la máxima:
a) Rapidez, economía y sencillez
b) Cantidad, velocidad y ahorro
c) Fiabilidad, reproducibilidad y calidad
d) Autonomía, independencia y creatividad

3. La competencia general del TSLCB consiste en:
a) Realizar estudios analíticos de muestras biológicas mediante protocolos normalizados y normas de calidad, seguridad y medioambientales
b) Vender productos hospitalarios
c) Diagnosticar enfermedades y firmar informes médicos
d) Extraer siempre las muestras a los pacientes

4. Los resultados obtenidos deben servir de soporte a:
a) Solo diagnóstico
b) Publicidad del laboratorio
c) Prevención, diagnóstico, control de evolución, tratamiento e investigación
d) Facturación y contabilidad

5. Los tres grupos de funciones del TSLCB son:
a) Técnicas, comerciales y forenses
b) Preanalíticas, analíticas y postanalíticas
c) Profesionales, personales y sociales
d) Clínicas, legales y económicas

6. Según la profe, la obtención de muestras la realizan:
a) El paciente en su casa
b) El delegado comercial
c) Otros profesionales; el técnico se encarga de la recepción
d) Siempre el técnico de laboratorio

7. Preparar la muestra para el análisis implica aplicar:
a) Tratamiento quirúrgico
b) Tratamiento preanalítico o pretratamiento
c) Tratamiento farmacológico
d) Tratamiento post analítico

8. Las determinaciones analíticas se realizan siguiendo:
a) Las indicaciones del paciente
b) Los protocolos normalizados de trabajo (PNT)
c) Las instrucciones del delegado comercial
d) La intuición del técnico

9. Poder seguir el recorrido de una muestra sin perderla se llama:
a) Reproducibilidad
b) Trazabilidad
c) Accesibilidad
d) Variabilidad

10. La gestión del control, según los procedimientos establecidos, se refiere a:
a) Horarios de los pacientes
b) Facturación del hospital
c) Existencias de almacén y equipos
d) Nóminas del personal

11. Una función a nivel personal es evaluar la:
a) Opinión de los pacientes
b) Rentabilidad económica del laboratorio
c) Popularidad del centro
d) Coherencia, reproducibilidad y fiabilidad de los resultados

12. Utilizar las aplicaciones informáticas sirve para:
a) Eliminar los protocolos
b) Asegurar mayor fiabilidad y menor manipulación (manual) de los resultados
c) Aumentar la manipulación manual
d) Evitar la trazabilidad

13. Para adaptarse a nuevas situaciones (en rojo) es necesario:
a) Repetir siempre los mismos ensayos
b) Trabajar sin protocolos
c) Mantenerse actualizado, formación continua y uso de las TIC
d) Evitar las nuevas tecnologías

14. Para resolver situaciones y problemas hace falta tener:
a) Únicamente conocimientos de informática
b) Solo antigüedad
c) Dependencia y pasividad
d) Iniciativa y autonomía

15. Desarrollar habilidades con creatividad implica:
a) Trabajar siempre solo
b) Fomentar la innovación y el espíritu de mejora

c) Evitar cualquier cambio
d) Copiar procedimientos de otros sin revisar

16. Es una función social del técnico:
a) Firmar el informe médico
b) Recetar medicamentos
c) Organizar y coordinar equipos de trabajo
d) Diagnosticar al paciente

17. El técnico debe supervisar y aplicar procedimientos de:
a) Prevención de riesgos laborales y ambientales, gestión de calidad y accesibilidad universal
b) Contabilidad y marketing
c) Cirugía menor
d) Prescripción farmacéutica

18. La accesibilidad universal significa:
a) Que el laboratorio abra 24 h
b) Que las muestras sean públicas
c) Que solo accedan los médicos
d) Que los procedimientos sirvan para todas las personas

19. Es una función social:
a) Participar activamente en la vida social, económica y cultural
b) Ignorar las opiniones de los demás
c) Evitar el liderazgo
d) No relacionarse con el equipo

20. La imagen de la diapositiva 8 representa:
a) Robótica de laboratorio
b) Protocolos de bioseguridad
c) Un marcapasos
d) Cultura en valores y ética

Bloque B · TSLCB: áreas, puestos, calidad y objetivos (21-41)

21. Sectores del TSLCB: ámbito público, empresas privadas, área del laboratorio de análisis clínicos y:
a) Sector funerario
b) Medicina forense
c) Atención primaria y especializada
d) Servicio de tratamiento realizando preparaciones

22. Las empresas privadas donde trabaja el técnico pueden ser:
a) Agencias de viajes
b) Farmacéuticas o biotecnológicas
c) Constructoras
d) Bancos y aseguradoras

23. Otros entornos laborales del técnico son:
a) Puestos de gestión e investigación
b) Transporte sanitario

c) Docencia universitaria y cirugía
d) Comercio minorista

24. La actividad profesional del técnico está regulada por:
a) Los colegios de médicos
b) Cada hospital por libre
c) Las empresas farmacéuticas
d) La administración sanitaria estatal

25. ¿Cuál es un puesto de trabajo del TSLCB?
a) Ayudante técnico de toxicología
b) Tanatopractor
c) Ayudante de forense
d) Citotécnico

26. ¿Cuál es un puesto de trabajo del TSLCB?
a) Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos
b) Técnico especialista en anatomía patológica y citología
c) Colaborador en biología molecular
d) Prosector de autopsias

27. El ambiente profesional del técnico es un laboratorio con:
a) Trabajo exclusivamente administrativo
b) Ausencia de normas
c) Responsabilidad grande, esfuerzo y trabajo
d) Poca responsabilidad

28. Se requieren profesionales:
a) Sin formación previa
b) Versátiles, capaces de desarrollar diferentes metodologías analíticas
c) Que solo sepan una técnica
d) Que eviten los cambios

29. La labor del técnico no consiste solo en repetir ensayos; también debe:
a) Adaptarse a la rapidez del avance de nuevas técnicas y proponer otras con constante formación
b) Delegar todas las técnicas
c) Rechazar las nuevas metodologías
d) Limitarse a la puesta a punto

30. ¿Cuál de estos es un avance tecnológico citado?
a) Pizarras de tiza
b) Fax
c) Máquinas de escribir
d) Autoanalizadores e inyectores automáticos

31. Respecto a los programas informáticos, NO es una necesidad citada:
a) Evitar actualizarlos para no cometer errores
b) Conocer la digitalización de imágenes
c) Conocer el avance de las casas comerciales y resolver incidencias
d) Saber manejarlos y aplicarlos

32. La gestión del laboratorio va desde:
a) El alta hasta el ingreso
b) La facturación hasta el cobro
c) La solicitud del análisis hasta el envío del resultado
d) La compra hasta la venta

33. Para la mejora de calidad hay que revisar los protocolos desde:
a) La compra de reactivos hasta su caducidad
b) La preparación del paciente para obtener la muestra hasta el envío de los informes
c) La llegada del técnico hasta su salida
d) El análisis hasta la limpieza

34. Para la calidad es necesario que el técnico sea:
a) Autosuficiente y capaz de aplicar correctamente los procedimientos
b) Solo observador
c) Dependiente del médico en cada paso
d) Ajeno a los protocolos

35. Según la imagen de bioseguridad, hay que lavarse las manos:
a) Cada 2 horas durante 20 segundos
b) Solo al terminar la jornada
c) Una vez al día
d) Cada 10 minutos durante 2 minutos

36. Un objetivo relacionado con la patología es relacionarla con la fisiopatología:
a) Sin documentación
b) Usando lenguaje coloquial
c) Aplicando terminología científico-técnica
d) Solo de forma oral

37. Gestionar la documentación del procesamiento de muestras exige conocer:
a) Los datos bancarios del paciente
b) El precio de cada reactivo
c) La marca del microscopio
d) La codificación y el registro de muestras sin perder la trazabilidad

38. Los errores que influyen en la variabilidad de los resultados vienen de:
a) El salario del técnico
b) La publicidad del laboratorio
c) Extracción, transporte, conservación y análisis
d) El color del tubo y la hora de comida

39. Un objetivo de análisis es:
a) Firmar el diagnóstico
b) Recetar el tratamiento
c) Seleccionar técnicas instrumentales apropiadas en función del análisis
d) Cobrar el análisis

40. Es un objetivo de la fase post analítica:
a) Aceptar los riesgos y la posibilidad de error
b) Transportar la muestra

c) Extraer la muestra
d) Preparar al paciente

41. En la fase post analítica, el tratamiento de datos se hace aplicando:
a) El estudio estadístico correspondiente
b) Una estimación sin datos
c) La intuición
d) El horóscopo

Bloque C · TSAPC (tu título) (42-60)

42. Las funciones del TSAPC son:
a) Funciones exclusivamente comerciales
b) Funciones de ayuda en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento e investigación
c) Funciones de dirección del hospital
d) Funciones de diagnóstico autónomo

43. NO es una función de la competencia general del TSAPC:
a) Optimizar los recursos
b) Colaborar en las necropsias clínicas y forenses
c) Vender productos farmacéuticos
d) Procesar muestras histológicas y citológicas

44. El TSAPC selecciona citologías:
a) Ginecológicas y generales
b) Veterinarias
c) Solo de orina
d) Solo de sangre

45. En la recepción de muestras del TSAPC, la obtención:
a) La hace siempre el técnico
b) No la suele realizar el técnico; se sigue el protocolo de unidad
c) No es necesaria
d) La hace el paciente

46. El TSAPC garantiza la conservación de muestras:
a) Solo durante el transporte
b) Desde la solicitud hasta el informe final
c) Solo dentro de la nevera
d) Hasta que llega al laboratorio

47. NO es una determinación analítica con PNT citada:
a) Análisis inmunológicos
b) Parámetros bioquímicos
c) Análisis hematológicos
d) Análisis radiológicos

48. Función específica del TSAPC:
a) Hacer ecografías
b) Recetar tratamientos ginecológicos

c) Operar al paciente
d) Relacionar el resultado de citologías ginecológicas en función de un patrón control

49. Las técnicas necrópsicas el TSAPC las realiza bajo supervisión de:
a) El tanatopractor
b) El patólogo
c) El paciente
d) El delegado comercial

50. Función específica del TSAPC:
a) Hacer análisis de agua potable
b) Aplicar anestesia
c) Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular
d) Programar software

51. El sector que tiene el TSAPC y no aparece en el TSLCB es:
a) Investigación
b) Empresas privadas
c) Ámbito público
d) Sector sanitario, en atención primaria y especializada

52. ¿Cuál es un puesto de trabajo del TSAPC?
a) Tanatopractor
b) Delegado comercial
c) Técnico especialista en laboratorio
d) Ayudante técnico de toxicología

53. ¿Cuál es un puesto de trabajo del TSAPC?
a) Delegado comercial
b) Prosector de autopsias clínicas y médico-legales
c) Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico
d) Ayudante técnico en laboratorio de investigación y experimentación

54. Según la profe, son disciplinas con entidad propia:
a) Cardiología, neumología y nefrología
b) Biología molecular, citogenética y bioinformática
c) Física, química y geología
d) Contabilidad, marketing y ventas

55. La incorporación de la robótica en el procesamiento de muestras citológicas e histológicas permite:
a) Realizar diagnósticos con fluidez
b) Evitar la calidad
c) Prescindir de protocolos
d) Eliminar al patólogo

56. El sector funerario requiere técnicos que sepan extraer del cadáver:
a) Documentos personales
b) Joyas
c) Tejidos, prótesis, marcapasos y otros contaminantes
d) Solo la ropa

57. Los objetivos específicos de análisis del TSAPC son:
a) Venta, compra, almacén, envío y cobro
b) Ámbito público, privado, laboratorio, tratamiento y gestión
c) Tinción, extensión, disección, extracción y detección
d) Prevención, diagnóstico, control, tratamiento e investigación

58. En los objetivos de desarrollo personal, el liderazgo sirve para facilitar:
a) La firma de diagnósticos
b) La compra de reactivos
c) La coordinación de equipos
d) La facturación

59. En los objetivos de desarrollo personal, la motivación sirve para facilitar:
a) La necropsia
b) La tinción
c) La extracción de muestras
d) La organización de equipos

60. Es un objetivo de desarrollo personal del TSAPC:
a) Ignorar los riesgos
b) Evitar la formación
c) Diagnosticar sin supervisión
d) Tener en cuenta el marco legal como ciudadano democrático y profesional

Bloque D · Repaso de detalles: ¿cuál NO es? y datos finos (61-80)

61. NO es una función profesional del TSLCB:
a) Verificar el funcionamiento de los equipos instrumentales y asegurar las normas de seguridad
b) Diagnosticar y firmar el informe médico
c) La organización del laboratorio en cuanto al área de trabajo
d) La distribución de las muestras biológicas según demandas clínicas y/o analíticas

62. NO es una función a nivel personal:
a) Vender reactivos a otros laboratorios
b) Utilizar aplicaciones informáticas para una menor manipulación manual de los resultados
c) Identificar la normativa de protección ambiental y personal
d) Garantizar que los resultados obtenidos son ciertos

63. NO es una función a nivel social:
a) Saber comunicar y utilizar vías eficaces de comunicación
b) Trabajar siempre aislado del equipo
c) Aportar soluciones a los conflictos al trabajar en grupo
d) Asegurar el uso eficiente de los recursos disponibles

64. NO es una función a nivel social:
a) Respetar las opiniones, la autonomía y la competencia del equipo
b) Responsabilidad social, ejercer derechos, cumplir obligaciones y aplicar principios éticos de salud

c) Ocultar errores para no preocupar al equipo
d) Generar entornos seguros de trabajo y estar al tanto de la gestión inicial básica de la empresa

65. La profe destaca en rojo que tanto los avances tecnológicos como la automatización requieren:
a) Que solo los ingenieros manejen los equipos
b) Que formadores y alumnos estén actualizados en nuevos programas informáticos
c) Que se vuelva a los métodos manuales
d) Que se dejen de usar los ordenadores

66. Lo primero que es necesario respecto a los programas informáticos es:
a) Saber programarlos desde cero
b) Saber repararlos físicamente
c) Saber venderlos
d) Saber manejar y aplicar estos programas

67. Conocer la patología implica relacionarla con los patrones de:
a) Facturación del centro
b) Consumo eléctrico del laboratorio
c) Alteración morfológica (tejido) o bioquímica
d) Horario del personal

68. NO es un objetivo personal del TSLCB (cajas de la diapositiva 15):
a) Usar aplicaciones informáticas para gestionar documentos y el control de existencias
b) Usar aplicaciones para organizar y gestionar el área de trabajo
c) Firmar diagnósticos anatomopatológicos
d) Distribución de hemoderivados y otras muestras de interés biológico

69. Un objetivo de análisis es la puesta en marcha de los equipos de análisis y su:
a) Mantenimiento
b) Publicidad
c) Venta
d) Desmontaje

70. NO es un objetivo de la fase post analítica:
a) Extraer sangre al paciente
b) Tener criterios para dar un informe verídico de los resultados
c) Utilizar programas informáticos de tratamiento de datos
d) Aplicar protocolos para garantizar el diseño y el proceso analítico

71. NO forma parte de la competencia general del TSAPC:
a) Seleccionar citologías ginecológicas y generales
b) Realizar intervenciones quirúrgicas
c) Procesar muestras histológicas y citológicas
d) Organizar el trabajo y cumplir los criterios de calidad

72. Entre las determinaciones analíticas con PNT del TSAPC está:
a) El análisis microbiológico en muestras biológicas y cultivos y las técnicas de análisis genéticos
b) La resonancia magnética

c) La radiografía de tórax
d) La ecografía abdominal

73. NO es una función específica del TSAPC:
a) Registrar los datos de necropsias clínicas legales
b) Relacionar el resultado de citologías no ginecológicas con un patrón control
c) Aplicar las técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares
d) Prescribir tratamientos oncológicos

74. En las funciones personales del TSAPC, las aplicaciones informáticas buscan:
a) Más manipulación manual
b) Eliminar la trazabilidad
c) Menos fiabilidad pero más rapidez
d) Mayor fiabilidad y menor manipulación manual de los resultados

75. En las funciones sociales del TSAPC se habla de aportar soluciones a los conflictos:
a) Al trabajar en grupo
b) En redes sociales
c) En el ámbito familiar
d) Con los proveedores únicamente

76. El entorno profesional del título de técnico de anatomía patológica y citodiagnóstico incluye:
a) Solo universidades
b) Ámbito público, sector sanitario (primaria y especializada), empresas privadas, laboratorio y servicio de tratamiento
c) Solo funerarias
d) Solo hospitales privados

77. ¿Cuál es un puesto de trabajo del TSAPC?
a) Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico
b) Delegado comercial de productos hospitalarios
c) Ayudante técnico de toxicología
d) Colaborador y asistente en biología molecular / colaborador y asistente de investigación

78. Los avances en las investigaciones están permitiendo descubrir:
a) Nuevos idiomas
b) Nuevos planetas
c) Nuevas monedas
d) Moléculas implicadas en diferentes procesos patológicos

79. En anatomía patológica, la calidad requiere:
a) Revisar los procedimientos una vez cada 10 años
b) Ignorar los riesgos laborales
c) Solo cumplir el horario
d) Revisión frecuente de los procedimientos y conocer mejoras en riesgos laborales y medioambiental

80. NO es un objetivo del TSAPC (patología, gestión o desarrollo personal):
a) Comunicación en grupo, actividad emprendedora, evolución científica y tecnológica y creatividad para poder innovar

b) Diagnosticar sin supervisión
c) Relacionar la patología con el proceso fisiológico y con el patrón morfológico y bioquímico
d) Uso de aplicaciones informáticas para gestión de documentos y gestión de existencias, y distribución de muestras de interés biológico

---

✔ SOLUCIONES

1 d	**2 c**	**3 a**	**4 c**	**5 c**	**6 c**	**7 b**	**8 b**	**9 b**	**10 c**
11 d	**12 b**	**13 c**	**14 d**	**15 b**	**16 c**	**17 a**	**18 d**	**19 a**	**20 d**
21 d	**22 b**	**23 a**	**24 d**	**25 a**	**26 a**	**27 c**	**28 b**	**29 a**	**30 d**
31 a	**32 c**	**33 b**	**34 a**	**35 a**	**36 c**	**37 d**	**38 c**	**39 c**	**40 a**
41 a	**42 b**	**43 c**	**44 a**	**45 b**	**46 b**	**47 d**	**48 d**	**49 b**	**50 c**
51 d	**52 a**	**53 b**	**54 b**	**55 a**	**56 c**	**57 c**	**58 c**	**59 d**	**60 d**
61 b	**62 a**	**63 b**	**64 c**	**65 b**	**66 d**	**67 c**	**68 c**	**69 a**	**70 a**
71 b	**72 a**	**73 d**	**74 d**	**75 a**	**76 b**	**77 d**	**78 d**	**79 d**	**80 b**

Reparto: 20 a · 20 b · 20 c · 20 d.

Puntuación: 72-80 = sobresaliente · 60-71 = notable · 48-59 = aprobado · < 48 = vuelve al Repaso.